

Cơ chế trụ Thiền

Bản nháp v0.1, ngày 04/10/2026. Tài liệu triển khai trụ thứ ba trong *Lý luận Lục Dưỡng v0.3*, cùng khung với *Cơ chế trụ Ấn uổng* và *Cơ chế trụ Luyện tập*. Ký hiệu: ☸ = Lục Dưỡng vận dụng; **[C1] [C2] [C3]** = cấp bằng chứng (mục IX của lý luận).

Cần thẩm định: trích dẫn kinh điển và tư liệu Phật giáo cần lương y và người có chuyên môn đối chiếu nguyên văn. Phần an toàn cần **chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần** duyệt. Các nghiên cứu nêu tên chỉ để định hướng, cần kiểm tra lại trước khi trích dẫn công khai.

Cách đọc tài liệu

Mỗi cơ chế là **chuỗi nhân quả từ một việc làm đến một trạng thái**, gồm bốn phần: **Động lý, Tây chứng, tăng được nuôi, trong app**.

Trụ Thiền có **một cơ chế nền và sáu cơ chế**, chia ba nhóm. Nhóm A đi theo phép "**tam điều**" cổ truyền: điều thân, điều tức, điều tâm.

Nhóm	Câu hỏi	Cơ chế
A. Tam điều	Thiền gồm những gì	1. Điều tức: hơi thở · 2. Điều thân: tư thế, thả lỏng · 3. Điều tâm: chú tâm, định
B. Quán	Thiền đưa đến đâu	4. Quán chiếu: nhận biết và buông, lòng tử tế với chính mình
C. Cách thực hành	Thiền thế nào trong đời sống	5. Thiền trong đời thường · 6. Liều lượng và thời điểm

Nền chung là **cơ chế gốc: tĩnh thì thần tàng**.

Hành chủ đạo: Kim (Phế chủ khí, chủ hô hấp; Kim tính thu liễm). **Tạng cùng tham gia:** tạng Tâm (tàng thần, chủ tình chí), Thận (tàng tinh, tàng chí). Việc gán hành là ☸.

Lập trường: thiền thế tục, tôn trọng mọi tín ngưỡng ☸

Thiền có gốc sâu trong Phật giáo, Đạo gia và văn hoá Việt. Trong Lục Dưỡng, thiền được trình bày như **một phép dưỡng sinh thế tục**: rèn sự chú tâm, hơi thở và sự bình an.

- Không yêu cầu người dùng theo tôn giáo nào. Người theo Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo hay không tôn giáo đều thực hành được.
- Khi nhắc nguồn gốc (Thiền Trúc Lâm, Làng Mai), nói với **thái độ trân trọng di sản**, không truyền giáo.
- Không dùng thiền để hứa hẹn những điều thuộc tâm linh hay siêu nhiên.

Cơ chế gốc: tĩnh thì thần tàng

Đông lý

- *Tổ VẤN, "Thượng cổ thiên chân luận": "Điểm đạm hư vô, chân khí tàng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tàng lai":* lòng điểm đạm, trống rỗng, thì chân khí thuận theo; tinh thần giữ ở bên trong, thì bệnh từ đâu mà đến.
- Cùng thiên mô tả bậc chân nhân **"hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần"**: thở hít tinh khí, đứng vững mà giữ thần.
- *Tổ VẤN, "Tý luận": "Âm khí giả, tĩnh tắc thần tàng, táo tắc tiêu vong"*: âm khí, tĩnh thì thần được tàng giữ, xao động thì hao mất.
- Tuệ Tĩnh: **"tồn thần, thanh tâm"** nằm trong bảy phép dưỡng sinh.

Chuỗi Đông lý: tâm tĩnh → thần được tàng ở tạng Tâm → thần ngự khí (khí thuận) → khí nhiếp tinh (tinh không hao) → thân an. Đây chính là **chiều dẫn dắt từ trên xuống** trong bốn tầng của lý luận (mục II).

Ngược lại, tâm xao động, lo nghĩ triền miên thì thần không yên, khí loạn, tinh hao. *Linh Khu, "Khẩu vấn": "Tâm động thì ngũ tạng lục phủ đều lay động".*

Tây chứng

Hiện tượng hiện đại	Tương ứng cổ truyền	Cấp
Căng thẳng kéo dài hoạt hoá trục dưới đồi – tuyến yên – thượng thận và hệ giao cảm; liên quan tăng huyết áp, rối loạn giấc ngủ, suy giảm miễn dịch	Tâm động thì ngũ tạng đều lay động	C1
Thiền chánh niệm giảm căng thẳng, lo âu, triệu chứng trầm cảm ở mức nhỏ đến vừa. Phân tích gộp của Goyal và cộng sự (JAMA Internal Medicine 2014): bằng chứng vừa phải cho lo âu, trầm cảm, đau; không tốt hơn các liệu pháp tích cực khác như tập thể dục hay trị liệu tâm lý	Điểm đạm hư vô, chân khí tàng chi	C1 (hiệu quả nhỏ – vừa)
Liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm (MBCT) giảm nguy cơ tái phát trầm cảm ở người đã từng trầm cảm nhiều lần (phân tích gộp của Kuyken và cộng sự 2016)	Sái hậu phòng phục	C1
Thay đổi cấu trúc, hoạt động não ở người thiền lâu năm	Thần được tàng	C2-C3 (kết quả chưa nhất quán)
Thiền làm chậm lão hoá tế bào (telomere)	Bệnh an tàng lai	C3

Hệ quả cho app 🍷

Mọi lời khuyên trả lời một câu: **việc này giúp tâm lắng xuống hay làm tâm xao động thêm?** Tín hiệu tự cảm nhận: **hơi thở chậm và êm hơn, vai cổ thả lỏng, ít bị cuốn vào suy nghĩ, dễ quay lại việc đang làm.**

Thông điệp trung thực: thiền là **phép dưỡng có lợi, hiệu quả vừa phải**, không phải phép màu và **không thay thế điều trị** trầm cảm, lo âu.

A. Tam điều

Phép **điều thân, điều tức, điều tâm** được hệ thống trong các sách tọa thiền cổ (thường dẫn *Tu tập chỉ quán tọa thiền pháp yếu* của Trí Khải đại sư; cần xác định xuất xứ). Thứ tự này cũng là thứ tự dễ học nhất: **thân yên trước, hơi thở theo sau, tâm lắng sau cùng**.

Cơ chế 1. Điều tức: hơi thở

Đông lý.

- Phế chủ khí, chủ hô hấp; Phế thuộc Kim, tính thu liễm.** Thở chậm, sâu, êm là cách trực tiếp nhất để thu liễm khí đang tán loạn.
- Trang Tử, "Khắc ý": "Xuy hư hô hấp, thổ cố nạp tâm":* thở ra cái cũ, hít vào cái mới. (*Cần đối chiếu.*)
- Đạo gia dạy thở xuống **đan điền**, tức vùng bụng dưới; Thận chủ nạp khí, nên thở sâu xuống bụng gắn với Thận.
- Phật giáo có *Kinh Quán niệm hơi thở* (Anapanasati): biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra. Đây là nền của phép thiền hơi thở trong truyền thống Làng Mai.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thở chậm (khoảng 6 nhịp/phút) tăng biến thiên nhịp tim, tăng hoạt động phó giao cảm (hệ "nghỉ ngơi và tiêu hoá")	C2
Thở ra dài hơn hít vào hỗ trợ cảm giác thư giãn	C2
Bài tập thở có kiểm soát giảm lo âu, căng thẳng tự báo cáo; một thử nghiệm nhỏ (Balban và cộng sự 2023) thấy bài "thở dài theo chu kỳ" 5 phút/ngày cải thiện tâm trạng	C2
Thở chậm có thể hạ huyết áp nhẹ	C2
Thở nhanh, sâu kéo dài (tăng thông khí) gây chóng mặt, tê tay; nín thở lâu trong nước có thể gây ngất, đuối nước	C1 (về nguy cơ)

Tăng được nuôi: Khí ●●●, Tâm ●●.

Trong app:

- Bài thở nền: **"thở bốn - sáu"**: hít vào khoảng 4 nhịp đếm, thở ra khoảng 6 nhịp đếm, trong 3-5 phút. Có vòng tròn hoặc âm thanh dẫn nhịp.
- Bài **"ba hơi thở"**: dừng lại, thở chậm ba hơi trước khi trả lời tin nhắn, trước cuộc họp. Ngăn đến mức ai cũng làm được.
- Không đưa vào** các kỹ thuật thở nhanh mạnh kéo dài hoặc nín thở lâu ở phiên bản đầu.

- Người dùng tự chọn: thở tự nhiên và chỉ quan sát, hoặc theo nhịp dẫn. Một số người thấy khó chịu khi bị "điều khiển" hơi thở.

Cơ chế 2. Điều thân: tư thế và thả lỏng

Đông lý.

- Ngồi thẳng mà không cứng: **"hư linh đỉnh kinh, hàm hung bạt bối"** (đỉnh đầu như treo nhẹ, ngực hơi thu, lưng thẳng) là yếu lĩnh tư thế trong Thái cực và thiền. *(Xuất xứ cần xác định.)*
- **Hình chính thì khí thuận**: thân ngay ngắn thì khí lưu thông, thân co gập thì khí trệ.
- Tư thế không bắt buộc ngồi kiết già: ngồi ghế, đứng, nằm đều có thể thiền.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thư giãn cơ tăng tiến (căng rồi thả từng nhóm cơ) giảm lo âu, cải thiện giấc ngủ	C1-C2
Quét cơ thể (body scan) là thành phần của chương trình MBSR, giúp nhận biết căng thẳng trong cơ thể	C2
Căng cơ vùng cổ vai kéo dài liên quan căng thẳng tâm lý và đau	C2

Tầng được nuôi: Thân ●, Khí ●, Tâm ●●.

Trong app:

- Bài **"quét thân"** 5-10 phút: đưa sự chú ý lần lượt từ đỉnh đầu đến bàn chân, thả lỏng chỗ đang căng.
- Bài **"thả vai"** 1 phút cho dân văn phòng: nhún vai lên, giữ, thả xuống, kết hợp thở ra dài. Nối với nhắc "đứng dậy" của trụ Luyện tập.
- Hướng dẫn tư thế linh hoạt: ngồi ghế, ngồi bệt, nằm (trước khi ngủ). Người đau lưng, người cao tuổi **không cần ngồi xếp bằng**.

Cơ chế 3. Điều tâm: chú tâm và định

Đông lý.

- **"Tinh thần nội thủ"**: giữ tinh thần ở bên trong, không để chạy theo ngoại cảnh.
- Phật giáo gọi là **chỉ** (samatha): dừng tâm lại trên một đối tượng (hơi thở, âm thanh, một câu niệm) cho đến khi tâm **định**.
- Tâm chạy theo suy nghĩ triền miên là **"tư"** thái quá, mà **"tư thương Tỳ"** (lý luận mục VI): lo nghĩ quá thì hại Tỳ, ăn không ngon, ngủ không yên.

Chuỗi Đông lý: tâm tán loạn → giữ tâm trên một điểm → tâm dần lắng → thần sáng, tư lự giảm → Tỳ không bị tổn, khí không bị loạn.

Tây chúng.

Hiện tượng	Cấp
Tâm lang thang là trạng thái rất phổ biến và liên quan tâm trạng thấp hơn (Killingsworth và Gilbert 2010, nghiên cứu quan sát)	C2
Thiền chánh niệm giảm suy nghĩ lặp đi lặp lại (nghiên ngẫm, lo lắng), một cơ chế quan trọng của trầm cảm và lo âu	C2
Thiền cải thiện một số khía cạnh của sự chú ý; mức độ và độ bền vững của tác dụng còn tranh luận	C2
Mạng lưới chế độ mặc định của não (hoạt động khi tâm lang thang) giảm hoạt động khi thiền	C2-C3

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thần ●●●.

Trong app:

- Bài "**đếm hơi thở**" 🕒: đếm từ 1 đến 10 theo mỗi hơi thở ra, lạc thì quay về 1. Không chê trách khi lạc: **nhận ra mình lạc là một lần tập thành công**.
- Lựa chọn đối tượng chú tâm: hơi thở, âm thanh xung quanh, cảm giác bàn chân, hoặc một câu ngắn người dùng tự chọn (có thể là câu cầu nguyện theo tín ngưỡng riêng).
- Không hứa "tâm trống rỗng". Mục tiêu là **nhận ra và quay về**, không phải không có suy nghĩ.

B. Quán

Cơ chế 4. Quán chiếu: nhận biết, buông, và lòng tử tế

Đông lý.

- Phật giáo gọi là **quán** (vipassana): sau khi tâm định, quan sát cảm xúc, suy nghĩ đến rồi đi mà không bám theo.
- Trần Nhân Tông, *Cư trần lạc đạo phú*: "**Cư trần lạc đạo thả tùy duyên**": sống giữa đời mà vui với đạo, hãy tùy duyên. Đây là tinh thần **Thiền Trúc Lâm**: thiền không tách khỏi đời sống. (*Cần đối chiếu nguyên văn.*)
- **Điểm đạm hư vô**: không phải vô cảm, mà là không để cảm xúc thái quá chiếm lấy (thất tình thái quá mới thành bệnh).
- Truyền thống Phật giáo có phép **từ bi quán**: nuôi lòng thương với mình và người.

Chuỗi Đông lý: cảm xúc khởi lên → nhận biết, gọi tên, không bám không đẩy → cảm xúc tự qua → không thành thất tình thái quá → năm tạng không bị tổn. Đây là chỗ trụ Thiền **phòng giữ nội nhân** (lý luận mục VI), cùng với trụ Cảm xúc.

Tây chúng.

Hiện tượng	Cấp
Gọi tên cảm xúc giảm cường độ phản ứng cảm xúc (nghiên cứu thực nghiệm về "gọi tên cảm xúc")	C2
Khả năng nhìn suy nghĩ như suy nghĩ, không như sự thật (tách bạch, decentering) là cơ chế giải thích tác dụng của MBCT	C2
Thực hành lòng trắc ẩn với bản thân (self-compassion) giảm tự phê phán, trầm cảm, lo âu	C2
Thiền từ bi (loving-kindness) tăng cảm xúc tích cực, cảm giác kết nối	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●●, Thân ●●.

Trong app:

- Bài **"gọi tên cảm xúc"** 🕒 3 phút: dừng lại, thở, tự hỏi "mình đang cảm thấy gì?", chọn tên từ bánh xe cảm xúc. Nối thẳng với nhật ký của trụ Cảm xúc.
- Bài **"thương mình"** 🕒 5 phút, câu chữ thể tục: "Mong mình được bình an. Mong mình được khoẻ mạnh. Mong mình đối xử dịu dàng với chính mình."
- Không đẩy người dùng vào việc đào sâu ký ức đau buồn. Quán trong app dừng ở **nhận biết cảm xúc hiện tại**.

C. Cách thực hành

Cơ chế 5. Thiền trong đời thường

Đông lý.

- Thiền Trúc Lâm: **thiền giữa đời**, không cần lên núi.
- Truyền thống Làng Mai (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) phổ biến **thiền đi, thiền ăn, thiền rửa bát, chuông chánh niệm**: mọi việc thường ngày đều là dịp thực hành.
- **Đạo dẫn** (trụ Luyện tập, cơ chế 4) là "thiền động": động tác chậm cùng hơi thở và chú tâm.

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Các thực hành chánh niệm ngắn, rải trong ngày (chánh niệm không chính thức) có liên quan với giảm căng thẳng, dù bằng chứng yếu hơn thiền chính thức	C2
Thói quen gắn với tín hiệu có sẵn trong ngày (gắn thói quen mới vào thói quen cũ) dễ duy trì hơn	C2
Đi bộ trong thiên nhiên giảm căng thẳng tự báo cáo	C2

Tăng được nuôi: Tâm ●●, Thân ●.

Trong app:

- **"Chuông chánh niệm"** 🕒: vài lần trong ngày (người dùng chọn giờ, có thể tắt), điện thoại phát một tiếng chuông nhẹ, nhắc dừng lại thở ba hơi.

- **Gắn thiền vào việc có sẵn** 🚗: ba hơi thở trước bữa ăn (nối trụ Ăn uống, "ba miếng đầu chánh niệm"), thiền đi trên đường đến chỗ làm, thở chậm khi chờ đèn đỏ (chỉ khi dừng xe an toàn).
- **Không gợi ý thiền khi đang lái xe**, vận hành máy móc, hay ở nơi cần tỉnh táo.

Cơ chế 6. Liều lượng và thời điểm

Đông lý.

- **Tiệm tiến** (pháp tắc 6): ít mà đều hơn nhiều mà bỏ.
- **Thuận thời**: sáng sớm thanh khí lên, dễ định tâm; tối trước khi ngủ, thiền giúp **"tâm yên thì ngủ"** (tạng Tâm và giấc ngủ, trụ Ngủ nghỉ).
- **Trung độ**: ngồi quá lâu, ép tâm quá mức cũng là thái quá. Trong truyền thống thiền có hiện tượng **"tẩu hoả nhập ma"** để chỉ những rối loạn khi tu tập sai cách hoặc quá sức. *(Lục Dưỡng không dùng cụm này với người dùng, chỉ ghi nhận như kinh nghiệm cổ truyền về rủi ro.)*

Tây chứng.

Hiện tượng	Cấp
Thực hành ngắn (khoảng 10 phút/ngày) đã có tác dụng trên căng thẳng tự báo cáo; tác dụng tăng theo sự đều đặn	C2
Chương trình chuẩn MBSR kéo dài 8 tuần, mỗi tuần một buổi nhóm và thực hành tại nhà khoảng 45 phút/ngày	C1 (về cấu trúc chương trình)
Thiền không phải lúc nào cũng dễ chịu. Một tỷ lệ người thực hành gặp tác dụng không mong muốn (lo âu tăng, ký ức đau buồn trở dậy, cảm giác tách rời bản thân); nguy cơ cao hơn khi thực hành cường độ cao, kéo dài ngày, hoặc ở người có tiền sử rối loạn tâm thần (Britton và cộng sự 2021)	C2
Thiền chánh niệm cải thiện chất lượng giấc ngủ ở mức vừa; với mất ngủ mạn tính , liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ (CBT-I) mới là điều trị hàng đầu	C1 (CBT-I) / C2 (thiền)

Tầng được nuôi: bảo vệ cả bốn tầng; chủ yếu Tâm ● và Thân ●.

Trong app:

- Liều khởi đầu: **3-5 phút/ngày**. Tăng dần đến 10-20 phút nếu người dùng muốn. **Không thách thức kiểu "thiền 60 phút"**.
- Hai khung giờ gợi ý: **sáng** (định tâm cho ngày mới) và **trước ngủ** (bài thở, quét thân, nối trụ Ngủ nghỉ).
- Đếm **số ngày có thực hành**, không đếm chuỗi ngày liên tục ("streak") theo kiểu gây áp lực; lỡ một ngày không bị "mất chuỗi".
- Không tổ chức khoá tu dài ngày, thiền cường độ cao trong phiên bản đầu. Nếu có, cần người hướng dẫn có chuyên môn và sàng lọc.

Tổng hợp: trụ Thiền nuôi bốn tầng

Cơ chế	Thân	Khí	Tâm	Thần	Lời khuyên chủ lực
0. Tĩnh thì thần tàng (nền)		●●	●●	●●●	(khung giải thích)
1. Điều tức		●●●	●●		Thở chậm, thở ra dài [C2]
2. Điều thân	●	●	●●		Quét thân, thư giãn cơ [C1-C2]
3. Điều tâm			●●	●●●	Đếm hơi thở; nhận ra và quay về [C2]
4. Quán chiếu			●●●	●●	Gọi tên cảm xúc; thương mình [C2]
5. Thiền đời thường			●●	●	Chuông chánh niệm; gắn vào việc có sẵn [C2]
6. Liều lượng, thời điểm			●	●	Ngắn mà đều; sáng và trước ngủ [C2]

Khớp với bảng của lý luận v0.3 (Thiền: Khí ●●, Tâm ●●, Thần ●●●). Khác với trụ Ăn uống và Luyện tập, phần lớn lời khuyên của trụ Thiền ở **cấp C2**; chỉ có tác dụng chung trên lo âu, trầm cảm và MBCT phòng tái phát ở cấp C1. Khi truyền thông cần nói đúng mức.

Thiền tác động sang các trụ khác

Đường nối	Cơ chế	Cấp
Thiền → Ngủ nghỉ	Kim sinh Thủy: thở chậm, tĩnh tâm thì dễ ngủ; tác động lên giấc ngủ ở mức vừa	C2
Ăn uống → Thiền	Thổ sinh Kim: ăn uống điều độ, không no căng thì dễ ngồi yên; ăn chánh niệm là cầu nối	C3 (vòng sinh) / C2 (ăn chánh niệm)
Thiền ↔ Cảm xúc	Quán chiếu, gọi tên cảm xúc phòng thất tình thái quá	C2
Thiền ↔ Luyện tập	Đạo dẫn, Thái cực, yoga là "thiền động"	C2
Thiền → Môi trường xã hội	Thiền từ bi tăng cảm giác kết nối; thiền nhóm tạo cộng đồng	C2
Môi trường → Thiền	Tiếng ồn, không gian chật, thiếu riêng tư làm khó thực hành; thiên nhiên hỗ trợ	C2

Đo lường trụ Thiền 📏

Theo nguyên tắc đo của lý luận (mục II): nhanh, ít gánh nặng, không gộp điểm, xem xu hướng.

Tự động

- **Số phút** và **số ngày** thực hành trong app.
- HRV từ đồng hồ (nếu có) **chỉ là dữ liệu tham khảo** cho thư giãn, **không** gọi là "đo Khí", **không** gọi là "đo độ sâu thiền" (lý luận mục II).

Trước và sau mỗi buổi (tùy chọn, 5 giây)

- "Lòng bạn lúc này yên đến đâu?" (0-10), hỏi trước và sau. App chỉ hiển thị xu hướng, không khen chê từng buổi.

Check-in hằng ngày

#	Câu hỏi	Trả lời	Cơ chế
1	Hôm nay bạn có dừng lại thở chậm hoặc thiền không?	Không · Vài hơi thở · 1-10 phút · >10 phút	1, 3, 5
2	Hôm nay bạn có hay bị cuốn vào suy nghĩ, lo lắng không?	Hiếm · Thỉnh thoảng · Thường xuyên	3, 4

Định kỳ (mỗi 2-4 tuần, cần chuyên gia chọn công cụ đã thẩm định tiếng Việt)

- **Thang căng thẳng cảm nhận** (ví dụ PSS-10).
- PHQ-4 và WHO-5 của tầng Tâm, tầng Thần (lý luận mục II) đã bao phủ phần lớn tác dụng của thiền.
- Câu hỏi về **trải nghiệm khó chịu khi thiền** (để phát hiện tác dụng không mong muốn).

Không đo

- Không chấm điểm "độ sâu" hay "chất lượng" buổi thiền.
- Không xếp hạng, không so sánh số phút với người khác.

An toàn riêng cho trụ Thiền

Bổ sung vào mục X của lý luận. **Cần chuyên gia tâm lý lâm sàng và bác sĩ tâm thần duyệt.** Đây là trụ có rủi ro tâm lý cao nhất trong sáu trụ, vì đi thẳng vào tầng Tâm và Thần.

Cờ đỏ khẩn cấp

Áp dụng nguyên mục X của lý luận: ý nghĩ tự hại hoặc không muốn sống thì **dừng mọi bài thiền**, hiển thị ngay số cấp cứu 115 và đường dây hỗ trợ tâm lý đã được xác minh.

Dừng buổi thiền và đổi hướng

Dấu hiệu trong hoặc sau buổi thiền	Hành động
Hoảng loạn, tim đập nhanh, khó thở khi chú ý vào hơi thở	Dừng. Mở mắt, nhìn quanh, gọi tên năm thứ nhìn thấy. Gợi ý đổi đối tượng chú tâm (âm thanh, bàn chân) hoặc thiền đi

Dấu hiệu trong hoặc sau buổi thiền	Hành động
Ký ức đau buồn, hình ảnh sang chấn ủa về	Dừng. Bài "neo về hiện tại" (mở mắt, cảm nhận bàn chân chạm đất). Khuyến trao đổi với chuyên gia nếu lặp lại
Cảm giác tách rời bản thân, mọi thứ không thật	Dừng. Neo về hiện tại; khuyến gặp chuyên gia nếu kéo dài
Chóng mặt, tê tay khi tập thở	Dừng bài thở; thở tự nhiên

Cờ đỏ cần đi khám, chuyên gia

Dấu hiệu	Hành động
Tắc dụng khó chịu lặp lại nhiều buổi hoặc kéo dài sau buổi thiền	Tạm dừng các bài thiền dài; khuyến gặp chuyên gia tâm lý
PHQ-4, WHO-5 vượt ngưỡng sàng lọc	Theo mục X của lý luận. Nói rõ thiền không thay thế điều trị
Mất ngủ ≥ 3 đêm/tuần kéo dài ≥ 3 tháng	Khuyến đi khám; CBT-I là điều trị hàng đầu

Khoá và điều chỉnh theo tình trạng

Tình trạng đã khai	Điều chỉnh
Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), tiền sử sang chấn nặng	Chỉ bài ngắn, mở mắt, hướng ra ngoài (âm thanh, chuyển động); không quét thân dài; khuyến thực hành cùng chuyên gia
Rối loạn loạn thần, rối loạn lưỡng cực (nhất là giai đoạn hưng cảm)	Khoá thiền dài, thiền im lặng; chỉ bài thở ngắn; hỏi bác sĩ điều trị
Trầm cảm nặng đang diễn tiến	Chỉ bài ngắn, nhẹ; ưu tiên kết nối điều trị. MBCT thường dành cho giai đoạn đã ổn định
Rối loạn hoảng sợ	Không bắt đầu bằng thiền hơi thở; dùng âm thanh, thiền đi
Động kinh, bệnh tim phổi, thai kỳ	Không dùng kỹ thuật thở nhanh mạnh hoặc nín thở

Lộ trình tiệm tiến gợi ý 🍃

Mỗi tuần **1-2 việc**, bắt đầu từ điều thân và điều tức:

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
1	Điều tức	"Ba hơi thở" 3 lần/ngày, gắn vào bữa ăn
2	Điều tức	"Thở bốn – sáu" 3 phút trước khi ngủ
3	Điều thân	"Quét thân" 5 phút, 3 buổi trong tuần
4	Điều tâm	"Đếm hơi thở" 5 phút buổi sáng
5	Quán chiếu	"Gọi tên cảm xúc" khi thấy căng thẳng
6	Đời thường	Bật "chuông chánh niệm" 2-3 lần/ngày; một buổi thiền đi

Tuần	Trọng tâm	Việc nhỏ
7-12	Ổn định	Một bài chính 10-15 phút/ngày, chọn khung giờ hợp mình

Hai lối vào theo bốn tầng (lý luận mục II):

- Người **căng thẳng, bất an** (Tâm, Thần yếu): thiền là cửa vào chính; bắt đầu bằng bài thở ngắn, không bắt đầu bằng ngồi im lâu.
- Người **mệt, suy nhược** (Thân, Khí yếu): thiền nằm, quét thân trước khi ngủ; ưu tiên ăn ngủ trước.

Việc cần hội đồng thẩm định

Lương y và người có chuyên môn về Phật học, Đạo học:

- Đối chiếu nguyên văn: *Thượng cổ thiên chân luận, Tý luận, Linh Khu "Khẩu vấn", Trang Tử "Khắc ý", Cư trần lạc đạo phú*; xuất xứ "tam điều" và yếu lĩnh tư thế.
- Cách trình bày Thiền Trúc Lâm, Làng Mai, *Kinh Quán niệm hơi thở* trong khuôn khổ thể tục, tôn trọng.
- Nội dung tôn thần, thanh tâm trong Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông.

Chuyên gia tâm lý lâm sàng, bác sĩ tâm thần:

- Bộ cờ đỏ riêng của thiền; quy trình dừng và neo về hiện tại.
- Khoá theo tình trạng (PTSD, loạn thần, lưỡng cực, trầm cảm nặng, hoảng sợ).
- Thư viện bài thiền: biên soạn, thu âm, độ dài, ngôn ngữ thể tục.
- Thang đo định kỳ (PSS-10 hoặc tương đương) bản tiếng Việt đã thẩm định.
- Xếp cấp C1/C2/C3 cho từng khẳng định.

Người có chuyên môn hướng dẫn thiền (ví dụ đã qua đào tạo MBSR, MBCT):

- Trình tự bài tập, cách hướng dẫn người mới, cách xử lý trải nghiệm khó.